

ITU / PNA · pediátrica

ITU febril no lactente é PNA até prova em contrário. Coleta adequada (cateter/punção) evita falso positivo; antibiótico precoce reduz cicatriz renal.

Coleta

Lembre - Coleta

Saco coletor serve para afastar (se negativo), não para confirmar. Diagnóstico confiável: cateterismo ou punção supra-púbica com urocultura.

Timeline: febre sem foco !' urocultura válida !' ATB !' USG e seguimento conforme idade/recorrência.



Conduta

- Lactente febril / tóxico: ATB EV empírico após coleta
- Criança maior com cistite típica: ATB VO pode bastar
- Ajustar conforme cultura e antibiograma
- Fatores de risco: fimose, constipação, disfunção miccional, refluxo

Imagem — visão clássica de prova

Exame | Quando pensar

USG vias urinárias | 1ª ITU febril / lactente

Uretrocistografia | USG alterado, ITU atípica/recorrente (protocolos variam)

Cintilografia DMSA | Avaliar cicatriz em selecionados

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Tratar 'ITU' só com leucócitos no saco coletor sem cultura adequada gera overtreatment. Confirme coleta válida antes de longos esquemas e investigação invasiva.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1